

CAPÍTULO 7.15

Síndrome de Cushing

PERFIL EUNACOM 1.03.2.013

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tiroiditis

Tipos

TABLA 7.15.1: TIPO VS CAUSA				
TIPO	CAUSA	CLÍNICA	FUNCIÓN TIROIDEA	TRATAMIENTO
Aguda	Bacteriana (supurativa)	Fiebre + bocio doloroso + eritema	Variable	ATB + drenaje quirúrgico
Subaguda (De Quervain)	Post-viral	Dolor + bocio + fiebre, VSG ↑↑	Fas es hiper → eutiroides → hipotiro → eutiroides	AINes / corticoides
Hashimoto	Autoinmune (ATPO +)	Asintomática; causa más frecuente hipotiro en adultos	Hipotiroidismo	Levotiroxina
Riedel	Fibrosis tiroidea	Bocio pétreo, no doloroso; puede comprimir tráquea/esófago	Hipotiroidismo	Cirugía
Post-parto	Autoinmune	Hipertiroidismo leve a las 2-4 sem post-parto → luego hipotiroidismo	Bifásica	Propranolol (hiper) → Levotiroxina (hipo)

Tiroiditis De Quervain — Detalle

- **Causa:** post-viral (paramyxovirus, citomegalovirus)
- **Clínica:** dolor cervical anterior + referido al oído
- **Laboratorio:** VSG muy elevada (> 50); TSH ↓ inicial + T4 libre ↑ (fase hiper)
- **Gammagrafía:** captación suprimida (hormona se libera sin nueva síntesis)

Fases evolutivas

1. Fase hipertiroides (semanas): T4 ↑, TSH ↓ 2. Fase eutiroides (transitoria) 3. Fase hipotiroides (transitoria): T4 ↓, TSH ↑ 4. Recuperación completa

EUNACOM CRITERIOS

De Quervain vs. Graves: ambas dan hipertiroidismo, pero De Quervain tiene **gammagrafía con captación nula** (no hay síntesis activa). Graves tiene captación elevada.

Tiroiditis de Hashimoto — Detalle

- **ATPO positivos** (anticuerpos antiperoxidasa tiroidea) → marcador de enfermedad autoinmune
- Puede presentarse con bocio indoloro o sin bocio
- Causa más frecuente de hipotiroidismo primario en países desarrollados

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 44 años consulta por aumento de peso progresivo de 12 kg, debilidad muscular proximal en muslos, estrías violáceas anchas (> 1 cm) en abdomen y equimosis espontáneas fáciles. Examen: cara de luna llena, giba dorsal, PA 155/95 mmHg e hirsutismo."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Síndrome de Cushing: sospecha clínica por fenotipo clásico. Tamizaje de primera línea (se requieren al menos 2 pruebas positivas): (1) Cortisol libre urinario en 24 horas; (2) Test de Nugent (cortisol post 1 mg de Dexametasona nocturna > 1.8 mcg/dL); (3) Cortisol salival nocturno x2. Una vez confirmado, se mide ACTH para clasificar en ACTH-dependiente (Enfermedad de Cushing hipofisiaria o tumor ectópico) vs ACTH-independiente (adenoma o carcinoma suprarrenal).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Síndrome de Cushing ≠ enfermedad de Cushing. La enfermedad es un tumor hipofisiario productor de ACTH.
- Clínica: obesidad centrípeta + atrofia muscular periférica + estrías violáceas + HTA + diabetes.
- Primera causa de muerte: infecciones (inmunosupresión por cortisol).
- Estudio: 1º confirmar (cortisol urinario/salival/prueba supresión corta), 2º localizar (ACTH + supresión larga), 3º imagen.
- ACTH alta + suprime con dosis alta = enfermedad de Cushing (hipófisis). ACTH baja + no suprime = causa suprarrenal.
- Causa más frecuente: corticoides exógenos. Tratamiento: reducir dosis.
- ACTH ectópica: sospechar cáncer de pulmón de células pequeñas.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME DE CUSHING)

PREGUNTA 1

Paciente con síndrome de Cushing confirmado. ACTH sérica elevada, prueba de supresión larga con dexametasona muestra supresión del cortisol. ¿Cuál es el diagnóstico y siguiente examen?

- A) Adenoma suprarrenal - TAC de suprarrenales
- B) Enfermedad de Cushing - RMN de hipófisis
- C) ACTH ectópica - Radiografía de tórax
- D) Corticoides exógenos - Suspender tratamiento
- E) Hiperplasia suprarrenal - TAC de suprarrenales

RESUMEN: SÍNDROME DE CUSHING

El síndrome de Cushing (hipercortisolismo) no es lo mismo que la enfermedad de Cushing (tumor hipofisiario productor de ACTH, segunda causa). Clínica: astenia (síntoma más frecuente), obesidad centripeta (cara de luna, cuello de búfalo, abdomen), estrías violáceas, atrofia muscular periférica (signo más frecuente), HTA secundaria, diabetes, osteoporosis, hirsutismo, hiperglicemia, hipocalemia, alcalosis. Primera causa de muerte: infecciones (por inmunosupresión). Estudio ordenado: 1º Confirmar hipercortisolismo (cortisol libre urinario 24h, cortisol salival nocturno, prueba de supresión corta con dexametasona). 2º Localizar causa (ACTH + prueba de supresión larga). ACTH alta + suprime con dosis alta = hipofisiaria (enfermedad de Cushing). ACTH baja + no suprime = suprarrenal. 3º Imagen (RMN hipófisis o TAC suprarrenales). Causas: corticoides exógenos (más frecuente), enfermedad de Cushing, adenoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal, ACTH ectópica (cáncer pulmón células pequeñas). Tratamiento: reducir corticoides exógenos o cirugía del tumor.